Gale, punaises de lit, BMR et BHRe

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

Diagnostiquer, traiter ensemble, protéger le linge et les locaux, signaler ; ne pas exclure.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME — médecin coordonnateur / d'établissement, IDEC, référent hygiène

À RETENIR

Gale : cas et contacts traités le même jour, linge le lendemain, tout recommencé à J8. Punaises : ni maladie ni isolement. BMR et BHRe en ESMS : précautions standard, pas de dépistage des contacts, pas d'exclusion de la vie collective.

Sources : HCSP, gale (09/11/2012) · CPias ARA, fiche-repère gale (14/02/2025) · CPias et ARS HDF, punaises (03/2024) · HCSP, BHRe (12/2019)

GALE : DIAGNOSTIC, CONTACTS, SIGNALEMENT

- **Commune** : prurit à recrudescence nocturne, sillons, vésicules perlées (espaces interdigitaux, poignets, aisselles, fesses, organes génitaux) ; dos et visage épargnés.
- **Hyperkératosique** (âgé, immunodéprimé) : croûtes, prurit faible, très contagieuse ; prélèvement parasitologique systématique, comme en cas d'épidémie.
- **Contacts** : 1er cercle (contact cutané prolongé, nursing) ; 2e (même collectivité) ; 3e (visiteurs).
- **Précautions contact** jusqu'à 48 h après traitement : chambre seule, surblouse à manches longues, gants ; **savon avant friction** ; personnel atteint : éviction 48 h.
- **Épidémie** : 2 cas à moins de 6 semaines dans la même collectivité → **signalement ARS** (portail), appui du CPias.

Sources : HCSP 2012 (avis et rapport) · CPias ARA (02/2025) · CSP R1413-79 2° · signalement.social-sante.gouv.fr

GALE : TRAITEMENT J1 · J2 · J8

- **J1** : cas et contacts **en même temps** (commune : 1er cercle ; hyperkératosique : 1er et 2e cercles). Ordonnance nominative pour chacun.
- **Ivermectine** (Stromectol) : **200 µg/kg** en prise unique, à jeun ; sécurité non établie < 15 kg.
- **Perméthrine 5 %** (Topiscab), dès 2 mois : tout le corps sauf visage, ≥ 8 h, à J0 et J8. **Benzoate de benzyle** (Ascabiol) : 24 h de contact (adulte).
- **J2** : linge des 3 derniers jours (8 si hyperkératosique) à 60 °C, ou en sac fermé 3 j (8 j), ou acaricide.
- **J8 à J10** : tout recommencer (CPias ; 2e dose d'ivermectine hors RCP en gale commune, HCSP 2012). Prurit possible 2 à 4 semaines ; guérison jugée à 4 semaines.

Sources : RCP Stromectol, Topiscab, Ascabiol (BDPM, MAJ 29/09/2026) · CPias ARA (02/2025) · HCSP 2012

PUNAISES DE LIT

- **Pas de maladie transmise**, pas de transmission interhumaine : pas d'isolement ni de refus d'admission. Risque : surinfection des lésions de grattage.
- Signes : piqûres groupées ou alignées ; déjections noires, traces de sang sur les draps ; identification de l'insecte.
- **Lutte mécanique** : effets en sac fermé ; linge lavé ou séché à 60 °C ; fragile à -20 °C 48 h ; aspiration, vapeur ; ne pas déplacer les meubles.
- Persistance ou extension : professionnel **certibiocide**, au moins 2 passages à 15 jours.
- Transfert : douche, vêtements propres, effets ensachés ; prévenir l'établissement d'aval et le transporteur.

Sources : CPias et ARS Hauts-de-France, conduite à tenir en présence de punaises de lit (03/2024) ; MARS n° 2023_17 du 26/10/2023

BMR ET BHRE EN ESMS

- **BMR** : SARM, EBLSE. **BHRe** : entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC), entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG).
- **Précautions standard** pour tous : mains, tablier (soins souillants), excreta. BHRe : chambre individuelle avec sanitaires si possible, petit matériel dédié, bionettoyage quotidien.
- **Pas d'exclusion** des espaces collectifs. **Pas de dépistage** des résidents ni des contacts ; porteur connu : seulement avant un transfert en MCO.
- Colonisation : pas d'antibiotique. Infection à BHRe : avis d'un référent antibiotique.
- Statut noté au dossier et au DLU ; établissement d'accueil informé.

Sources : HCSP, BHRe, 11/12/2019, R6, R43-R48, R51-R52, R57 · CPias Hauts-de-France, résident porteur de BMR/BHRe (03/2022)

ÉPISODE DE GALE : CHECK-LIST

- ☐ Liste des cas et des contacts (résidents, professionnels, familles, intervenants) ; date J1 commune ; ordonnances pour tous
- ☐ Personnes < 15 kg, enceintes ou allaitantes repérées (choix du traitement) ; EPI, linge propre, sacs, acaricide, blanchisserie prévenue
- ☐ Santé au travail informée (maladie professionnelle, tableau 76) ; familles et visiteurs informés ; J8-J10 programmé
- ☐ Pas de pulvérisation d'acaricide dans les locaux pour une gale commune (indispensable si croûteuse) ; pas de retraitement pour un prurit résiduel

Sources : CPias ARA, fiche-repère gale (14/02/2025) · HCSP 2012 · CPias Bretagne, gale en EHPAD (MAJ 23/05/2025)

SIGNALER

Infection associée aux soins inhabituelle par sa résistance (**toute BHRe**), **cas groupés** (gale, BMR) ou **décès** : déclaration sans délai à l'ARS par le portail, qui vaut signalement L331-8-1. En EHPAD, le médecin coordonnateur peut prescrire en cas de risque collectif (gale) ; médecins traitants informés.

Sources : CSP R1413-79 · HCSP 2019, R65-R67 · CASF D312-158 12°

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.

Vision Moderne de la Santé
Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.